

Colpocléisis (Fermeture du vagin)

WARWIKI

Information pour le patient · Une correction durable du prolapsus par fermeture du vagin

Le colpocléisis (fermeture du vagin) est une chirurgie très efficace et bien tolérée pour le prolapsus des organes pelviens. Elle consiste à **fermer la majeure partie du canal vaginal** afin de maintenir les organes en place de façon permanente. Parce qu'elle ferme le vagin, cette intervention est choisie par les personnes qui sont certaines de ne plus souhaiter avoir de rapports vaginaux. Elle est rapide, bien tolérée et très efficace — une excellente option, notamment aux âges avancés ou en cas de problèmes de santé.

À propos de cette intervention

Plutôt que de reconstruire les soutiens, le colpocléisis **retire une bande de muqueuse vaginale et rapproche les parois par des points de suture**, raccourcissant et fermant le canal pour que les organes ne puissent plus descendre. Il peut être réalisé avec l'utérus en place ou après son ablation. Cette approche évite une longue reconstruction : elle est plus rapide et moins risquée que les autres chirurgies du prolapsus, avec un taux de succès supérieur à **90 %**.

La décision essentielle

Un point fondamental : après un colpocléisis, **les rapports vaginaux ne sont plus possibles**, et ce changement est définitif. Pour les personnes qui en sont certaines, la satisfaction est très élevée. Votre équipe soignante vérifiera que cette option vous convient et qu'il n'y a pas d'autres préoccupations (comme la nécessité d'examiner l'utérus) avant de procéder.

COMPRENDRE LES TERMES

Prolapsus

Descente des organes pelviens provoquant une sensation de boule ou de pression.

Colpocléisis

Chirurgie qui ferme la majeure partie du vagin pour soutenir les organes.

Chirurgie oblitérante

Correction qui ferme (plutôt que reconstruit) le vagin.

LeFort

Variante du colpocléisis réalisée avec l'utérus en place.

Bandelette (sling)

Soutien parfois posé en même temps pour corriger les fuites urinaires.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention est réalisée sous anesthésie (souvent rachianesthésie ou anesthésie générale), vous ne ressentez donc rien pendant l'opération, et elle est généralement courte. Ensuite, la plupart des personnes n'ont qu'un léger inconfort et récupèrent rapidement — c'est l'une des récupérations les plus faciles parmi les chirurgies du prolapsus.

Comment vous préparer

- Être **certaine de votre décision** de ne plus avoir de rapports vaginaux.
- Suivre les **instructions d'anesthésie** (jeûne, arrêt des anticoagulants selon les consignes).
- Une évaluation préopératoire ; une **bandelette peut être ajoutée** si vous avez aussi des fuites urinaires.
- Prévoir un accompagnant et de l'aide à domicile.

Déroulement

- 1 Vous êtes sous anesthésie ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Des bandes de muqueuse vaginale sont retirées et les parois sont **suturées ensemble**, fermant le canal.
- 3 Une sonde et parfois un méchage vaginal temporaire sont mis en place brièvement.

Après la chirurgie

- Souvent retour à domicile **le jour même ou après une nuit** ; récupération légère.
- Une sonde pendant un court moment ; quelques pertes sont normales.
- **Évitez les efforts et la constipation** pendant plusieurs semaines.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Des saignements abondants
- L'impossibilité d'**uriner** après le retrait de la sonde
- Des douleurs pelviennes qui s'aggravent

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Le colpocléisis ferme la majeure partie du vagin pour corriger le prolapsus — rapide, très durable, idéal pour une correction simple et peu risquée.
2. La conséquence est permanente : **les rapports vaginaux ne sont plus possibles** — cette intervention s'adresse à celles qui en sont certaines.
3. La récupération est généralement facile. Évitez les efforts et appelez en cas de fièvre, de saignements abondants ou de difficulté à uriner.